

UCLOUVAIN · CLINIQUES UNIVERSITAIRES SAINT-LUC

Vieillessement & Médecine gériatrique

Synthèse complète orientée examen — WMDS2238



Couvre l'intégralité des supports de cours + les thèmes des examens 2017–2025.

 Encadrés « TUYAU » remplis pour chaque question récurrente · Glossaire des abréviations

Banque de questions d'examen (réelles & probables) avec réponses · 2026

Table des matières

PARTIE I — Fondements de la gériatrie

- 1 Vieillesse, démographie & prévention
- 2 Fragilité & déclin fonctionnel
- 3 EGS & syndromes gériatriques
- 4 Outils diagnostiques & échelles
- 5 PSG & interdisciplinarité
- 6 Réadaptation gériatrique

PARTIE II — Grands syndromes gériatriques

- 7 Chutes & syndrome de désadaptation psychomotrice
- 8 Delirium (confusion aiguë)
- 9 Démence / troubles neurocognitifs majeurs
- 10 Dépression & psychiatrie de la personne âgée
- 11 Déficiences sensorielles
- 12 Dénutrition & syndrome de renutrition
- 13 Troubles de l'élimination
- 14 Troubles hydro-salins
- 15 Infections de la personne âgée
- 16 Ostéoporose, fractures & escarres
- 17 Constipation & diarrhée

PARTIE III — Cardio, urgences & médicaments

- 18 Cardio-gériatrie
- 19 Urgences & soins intensifs
- 20 Pharmacologie & déprescription
- 21 Conciliation médicamenteuse & concordance

PARTIE IV — Éthique, organisation & fin de vie

- 22 Capacité de discernement, projet thérapeutique, palliatif & aidants

ANNEXES

- A Glossaire complet des abréviations
- B Banque de questions d'examen (réelles & probables) + réponses

Légende :  **TUYAU** = question tombée plusieurs fois aux examens, réponse fournie ·  **Piège** = confusion classique ·  **À retenir** = point-clé.

Glossaire des abréviations

Chaque abréviation est aussi développée à sa première apparition dans le texte. Référence rapide :

5M — Mind, Mobility, Medication, Multi-complexity, Matters Most

ADL / AVJ — Activities of Daily Living / Activités de la Vie Journalière (de base)

IADL / AVJi — Instrumental ADL / Activités Instrumentales de la VJ

EGS (CGA) — Évaluation Gériatrique Standardisée (Comprehensive Geriatric Assessment)

PSG — Programme de Soins pour le patient Gériatrique

LIG / EGL — Liaison Interne Gériatrique / Équipe de Gériatrie de Liaison

CAM — Confusion Assessment Method

TNCM — Trouble NeuroCognitif Majeur (ex-« démence »)

MCI — Mild Cognitive Impairment (trouble cognitif léger)

SPCD — Symptômes Psycho-Comportementaux des Démences

CFS — Clinical Frailty Scale (Échelle Clinique de Fragilité)

DF — Déclin Fonctionnel

HO — Hypotension Orthostatique

HTA — HyperTension Artérielle

IC — Insuffisance Cardiaque ; **FEVG** — Fraction d'Éjection du VG

HFpEF — IC à fraction d'éjection préservée

FA — Fibrillation Auriculaire

IDM — Infarctus Du Myocarde

USI — Unité de Soins Intensifs

DFG / GFR — Débit de Filtration Glomérulaire

IR — Insuffisance Rénale

CPK — CréatinePhosphoKinase

CRP — C-Reactive Protein (protéine C-réactive)

MNA(-SF) — Mini Nutritional Assessment (Short Form)

GLIM — Global Leadership Initiative on Malnutrition

SRI — Syndrome de Renutrition Inappropriée

GDS — Geriatric Depression Scale

MMSE — Mini Mental State Examination (Folstein)

MoCA — Montreal Cognitive Assessment

MIF — Mesure d'Indépendance Fonctionnelle

TUG — Timed Up and Go (test)

SPPB — Short Physical Performance Battery

G8 / ISAR / SHERPA — outils de dépistage (oncogériatrie / urgences / déclin fonctionnel)

STOPP / START — Screening Tool of Older Persons' Prescriptions / to Alert to Right Treatment

EIM — Événement Iatrogène Médicamenteux

BZD — Benzodiazépine

IEC — Inhibiteur de l'Enzyme de Conversion

ARA II / sartan — Antagoniste des Récepteurs de l'Angiotensine II

BB — Bêta-Bloquant

AINS — Anti-Inflammatoire Non Stéroïdien

IPP — Inhibiteur de la Pompe à Protons

ISRS — Inhibiteur Sélectif de la Recapture de la Sérotonine

THS — Traitement Hormonal Substitutif

SERM — Selective Estrogen Receptor Modulator

PTH — ParaThormone ; **RAA** — Rénine-Angiotensine-Aldostérone

ADH — Hormone AntiDiurétique (vasopressine)

MRSA — Staphylocoque doré résistant à la mécilline

BLSE — Bêta-Lactamases à Spectre Étendu

PNA — PyéloNéphrite Aiguë

TR / TV — Toucher Rectal / Toucher Vaginal

DMLA — Dégénérescence Maculaire Liée à l'Âge

MR / MRS — Maison de Repos / et de Soins

MG / MT — Médecin Généraliste / Médecin Traitant

ICOPE — Integrated Care for Older People (OMS)

CARE — Compréhension, Appréciation, Raisonnement, Expression (discernement)

SPLATT — Symptoms, Previous falls, Location, Activity, Time, Trauma (chute)

DIAPPERS — causes réversibles d'incontinence (voir ch. 13)

FR / FP — Facteur de Risque / Facteur Protecteur

AVC — Accident Vasculaire Cérébral

OMI — Œdèmes des Membres Inférieurs

PA — Personne Âgée

DT2 — Diabète de Type 2

ACP — Advance Care Planning (planification anticipée des soins)

PARTIE I — Fondements de la gériatrie

1 Vieillissement, démographie & prévention

Schoevaerdt — Introduction, biologie du vieillissement, complexité, prévention.

TUYAU — Les « 5 M » de la gériatrie ≥ 2 × (2025, 2022)

« Citez les 5 M de la gériatrie » / « Quel ne sera pas le rôle du gériatre du futur ? »

Mind (cognition, delirium, dépression) · **Mobility** (marche, équilibre, chutes) · **Medications** (polypharmacie, déprescription) · **Multi-complexity** (multimorbidité, bio-psycho-social) · **Matters Most** (préférences/projet du patient).

Rôles futurs du gériatre = **spécialiste de la complexité**, consultant, pédagogue, rééducateur, leader de système de santé — **PAS « spécialiste d'une pathologie d'organe »**.

1.1 Vieillissement normal (« usuel ») — physiologie

Le vieillissement est **spontané, programmé, irréversible et physiologique** : ↓ des réserves fonctionnelles et de la capacité à répondre au stress, **variable selon les organes** (« vieillissement différentiel »).

Système	Modification physiologique
Composition corporelle	↓ masse maigre (muscle, eau : 60 % → 50 %) · ↑ masse grasse (+200 %, redistribution intra-abdominale)
Rénal	↓ néphrons, ↓ DFG (DFG), ↓ pouvoir de concentration, ↓ RAA et ↓ ADH
Cardiovasculaire	↓ compliance (rigidité artérielle → ↑ TA systolique/pulsée), débit de repos conservé , ↓ réponse β-adrénergique (↓ adaptation à l'effort)
Immunité	Immunosénescence : ↓ LT (surtout naïfs), ↓ réponse vaccinale ; barrières épithéliales ↓
Thermorégulation	↓ → tendance à l' hypothermie et fièvre atténuée
Digestif	Transit ralenti ; absorption globalement conservée

Modèle 1 + 2 + 3 de Bouchon (1984)

Le seuil d'insuffisance d'une fonction est franchi par la conjonction de : **(1)** déclin physiologique du vieillissement (ne franchit jamais seul le seuil) ; **(2)** maladie chronique ; **(3)** facteur aigu de décompensation (réversible si traité). → explique la **décompensation « en cascade »**.

1.2 Démographie & transition épidémiologique

- **Espérance de vie** ≠ **EV sans incapacité** (EVSI ≈ 12,5 ans à 65 ans) ≠ **EV en bonne santé**. Durée de vie moyenne ↑ mais **maximale stable** (≈ 122 ans).
- **3 transitions démographiques** : (1) ↓ mortalité **néonatale/infectieuse** ; (2) ↓ mortalité des « **maladies de civilisation** » ; (3) recul des maladies **liées à l'âge**.
- **Multimorbidité** (= ≥ 2 maladies actives = comorbidité/polypathologie active) : 64 % des > 65 ans. ≠ « > 4 diagnostics » et ≠ **antécédents**.

TUYAU — Étude Stuck (Lancet 1993) sur l'EGS 2017 Q4

« Quel outcome n'a PAS été pris en compte / amélioré ? »

L'EGS améliore : **maintien à domicile** (OR 1,26), **fonction cognitive** (1,41), ↓ **ré-hospitalisation** (0,88), ↓ **mortalité à 12 mois** (0,86). La « **qualité de vie** » n'était pas un critère de jugement de cette méta-analyse.

TUYAU — Exemple pour chaque niveau de prévention ≥ 2× (2023, 2022)

« Donnez un exemple de prévention primaire / secondaire / tertiaire / quaternaire. »

Niveau	But	Exemple gériatrique
Primaire	↓ l'incidence (agir sur les FR)	Vaccination (grippe, pneumocoque), activité physique, hygiène bucco-dentaire
Secondaire	Détection précoce	Dépistage du cancer, des FR cardiovasculaires, de la fragilité (G8, ICOPE)
Tertiaire	↓ progression / complications	Calcium + vitamine D après fracture, revalidation, soins dentaires d'une parodontite
Quaternaire	Éviter la surmédicalisation	Arrêt des bisphosphonates/statines en fin de vie, déprescription, Advance Care Planning

Pièges

- Au repos, le **débit cardiaque est conservé** ; c'est l'**adaptation à l'effort** qui chute.
- Un **DFG bas chez l'âgé** peut être physiologique (≠ maladie) — modèle 1+2+3.
- Comorbidité = pathologies **actives** (pas les antécédents).

2 Fragilité & déclin fonctionnel

de Saint-Hubert — Healthy ageing, fragilité, sarcopénie, déclin fonctionnel.

TUYAU — Critères de Fried (phénotype de fragilité) ≥ 2× (2019, 2021...)

« Quels critères de Fried la patiente présente-t-elle ? » / vignette « masse pancréatique, dépendante AVJi ».

5 critères : ① **perte de poids** involontaire > 4,5 kg/an · ② **épuisement** (fatigue) · ③ **faiblesse** (force de préhension, quintile inférieur) · ④ **lenteur** de la marche (quintile inférieur) · ⑤ **activité physique faible** (quartile inférieur).

0 = robuste · 1-2 = pré-fragile · ≥ 3 = fragile.

TUYAU — Choisir une échelle de fragilité : sur quoi se baser ? ≥ 2× (2022, 2021)

« Sur quels 3 critères choisir la méthode d'évaluation de la fragilité ? » + « 3 qualités d'une bonne échelle ».

3 critères de choix : ① le **but** de l'évaluation (clinique / recherche / préopératoire) · ② le **critère évalué** (mortalité, déclin fonctionnel, prévention) · ③ la **population ciblée** (âge, lieu de vie).

Qualités d'une bonne échelle : validée, reproductible, faisable/rapide, valeur pronostique, multidimensionnelle.

 TUYAU — Cas « veuf/aidant fatigué, amaigri, s'isole » : signes de fragilité ≥ 2× (2023, 2020)

« Citez 4 signes de fragilité de ce patient. »

Amaigrissement / perte de poids · fatigue (épuisement) · ↓ activité & sorties (sédentarité) · lenteur de marche / faiblesse · isolement social (+ deuil = facteur précipitant). Ce sont les critères de Fried appliqués à la vignette.

2.1 Définition & modèles

Fragilité = diminution des réserves multisystémiques et de la capacité à **maintenir/récupérer un équilibre face à un stress** → vulnérabilité accrue. **Processus dynamique et réversible**, distinct de la comorbidité et de l'incapacité (3 éléments de définition souvent demandés : *processus dynamique/réversible · ↓ réserves face au stress · risque de déclin fonctionnel et d'événements défavorables*).

- **Phénotype de Fried** (modèle catégoriel, 5 critères ci-dessus) vs **index de Rockwood** → CFS à **9 niveaux** (1 très en forme ... 7 sévèrement fragile ... 9 phase terminale < 6 mois ; +21 % mortalité / échelon).
- **Sarcopénie** = perte de **masse ET de fonction** musculaire (dépistage SARC-F). Attention à l'**obésité sarcopénique**.
- **Fragilité ≠ comorbidité** : 75 % des fragiles sont multimorbides, mais seulement 16 % des multimorbides sont fragiles.

2.2 Déclin fonctionnel (DF) & hospitalisation

 TUYAU — Conséquences du déclin fonctionnel post-hospitalisation ≥ 3× (2021, 2019, 2018)

« 4 conséquences du déclin fonctionnel après hospitalisation » + QCM « la fausse ».

- Le DF touche **~30 % des ≥ 75 ans**, débute dans les **48 h**, persiste à 3 mois chez **1 patient sur 3**.
- **Conséquences** : ↑ durée de séjour · ↑ réadmissions · ↑ **institutionnalisation** (placement en MRS) · ↑ mortalité · perte d'autonomie/aides accrues.
- **PIÈGE** : le DF survient **PLUS VITE** chez le patient **FRAGILE** (réserves basses), pas chez le robuste (qui a un seuil plus élevé).

Facteurs précipitants intra-hospitaliers : immobilisation, sondes/perfusions, jeûne (timing des examens), iatrogénie, isolement. **Prévention** = unité de gériatrie + mobilisation précoce + EGS.

Pièges

- La fragilité est **réversible** ; **CFS 9 (terminal) ≠ 7 (sévère)**.
- Sarcopénie = masse **ET** fonction.
- Facteur de **mauvais** pronostic de revalidation = **déclin fonctionnel chronique** (et non un événement aigu limité, qui est de meilleur pronostic).

3 EGS & syndromes gériatriques

TUYAU — Définition / 5 caractéristiques de l'EGS TRÈS RÉCURRENT

« Donnez 5 caractéristiques (définition) de l'EGS. »

L'EGS est un **processus** : ① **multidimensionnel** (scores validés) · ② **interdisciplinaire** (équipe qui communique) · ③ qui aboutit à un **plan de soins individualisé, intégré et coordonné** · ④ visant à **améliorer la fonction et la qualité de vie** · ⑤ avec **suivi/réévaluation** dans le temps.

TUYAU — Dimensions de l'EGS + test de dépistage de chacune

TRÈS RÉCURRENT (cas anémie ferriprive + lésion colique)

« Citez 5 dimensions de l'EGS et le test adéquat pour chacune. »

Dimension	Outil / acronyme
Fonctionnel — AVJ de base	Katz (ADL)
Fonctionnel — AVJ instrumentales	Lawton (IADL)
Locomoteur / équilibre	Timed Up & Go , Tinetti
Cognitif	MMSE / MoCA / Mini-Cog / Codex
Thymique (humeur)	GDS (mini-GDS)
Nutritionnel	MNA + poids
Médicamenteux	STOPP / START
Socio-familial / sensoriel	évaluation sociale ; audition (chuchotement), vision (acuité)

TUYAU — EGS « ciblée, active, de longue durée » ≥ 2× (2022, 2021)

« Expliquez chaque composante en 1 ligne. »

- **Ciblée** : réservée aux PA à risque (dépistage préalable : G8, ISAR...), car le processus est long et coûteux.
- **Active** : elle débouche sur une **intervention** (plan de soins), pas seulement un constat.
- **Longue durée** : avec **suivi** et réévaluation des résultats dans le temps.

TUYAU — Bénéfices de l'EGS (général & oncogériatrie) TRÈS RÉCURRENT

« 5 objectifs/bénéfices favorables de l'EGS » / « 3 bénéfices pour un patient onco ».

Bénéfices : ↑ maintien à domicile/autonomie · ↓ mortalité · ↓ institutionnalisation · ↓ ré-hospitalisation · ↑ qualité de vie · (↓ coûts). **En oncogériatrie** : ① évaluer le **pronostic** et la tolérance prévisible des traitements · ② **adapter/dé-intensifier** le traitement (↓ toxicité) · ③ **détecter d'autres problèmes** et y intervenir (fonction, nutrition...). **Utile seulement si suivie d'une intervention.**

3.1 Syndromes gériatriques

TUYAU — Caractéristiques communes des syndromes gériatriques **TRÈS RÉCURRENT**

« 3 (ou 4) points communs des syndromes gériatriques. »

Fréquents · Multifactoriels (facteurs de risque communs) · Sévères/coûteux · Sous-diagnostiqués · Prévenables & curables. Ils touchent surtout le sujet **fragile** ; le **déclin fonctionnel en est une conséquence** (et un FR partagé). **FR communs** : âge élevé, troubles cognitifs, troubles de la mobilité, incapacités AVJ.

Exemples (les « i ») : **I**nstabilité (chutes), **I**mmobilité, **I**ncontinence, **I**ntellect (delirium/démence), **I**atrogénie, + dénutrition, déficits sensoriels. Chaque syndrome = « **red flag** » de **fragilité**, jamais à banaliser → déclenche une EGS.

Pièges

- L'EGS **n'est pas** centrée uniquement sur médicaments/maladies, ni un outil de 1^{re} ligne (le **dépistage** la précède).
- **GDS** évalue un **risque** de dépression, ce n'est pas un diagnostic ; **Katz ≠ Lawton** (pas interchangeables).
- En oncogériatrie, l'EGS n'est utile que **si elle modifie la prise en charge**.

4 Outils diagnostiques & échelles

Boland — Performances des tests, échelles fonctionnelles & de dépistage.

TUYAU — G8 : pourquoi le préférer en oncogériatrie ? **RÉCURRENT (2024, 2025)**

« Pourquoi préférer le G8 à l'ISAR/SHERPA ? » + « 2 avantages d'un dépistage avant l'EGS ».

Le **G8** est **validé et conçu pour l'oncogériatrie**, **sensible**, court et inclut un item nutritionnel — meilleur pour **dépister qui adresser à l'EGS**. **Avantages d'un dépistage préalable** (G8 < 14/17 → EGS) : ① cibler/économiser l'EGS (longue) sur les patients à risque · ② éviter le sur- et le sous-traitement en objectivant la vulnérabilité.

4.1 Échelles fonctionnelles & de performance

Échelle	Mesure	Repère / seuil
Katz (ADL)	6 AVJ de base : laver, habiller, transfert, toilette, continence, manger	score de dépendance (bas = autonome)
Lawton (IADL)	AVJ instrumentales : téléphone, courses, repas, ménage, transports, finances, médicaments	score d'indépendance (haut = autonome)
MIF	Mesure d'Indépendance Fonctionnelle — suivi en réadaptation	multidimensionnelle, valide jeune + âgé
TUG	se lever, marcher 3 m, demi-tour, se rasseoir → dépiste le risque de chute	normal < 14 s (≥ 20 s = kiné)
SPPB	équilibre + vitesse de marche + lever de chaise → sarcopénie/mobilité	/12
Tinetti / Berg	équilibre & marche (risque de chute)	Berg très spécifique
G8 / ISAR / SHERPA	dépistage : oncogériatrie / urgences / risque de déclin fonctionnel	G8 ≤ 14/17 → EGS
MMSE / MoCA / Mini-Cog	cognition	≤ 24/30 · ≤ 26/30 · < 3/5
CAM-3M	delirium	le plus performant (RV+ 18,6)
MNA-SF / GDS	nutrition / dépression	≤ 7/14 dénutri · GDS-4 ≥ 2/4

Pièges

- **TUG < 15 s = correct** ; le TUG **dépiste le risque de chute** (pas un diagnostic). Aucun outil de chute isolé n'est suffisant → en associer 2.
- **Katz** = score de **dépendance** (bas = autonome) ; **Lawton** = score d'**indépendance** (haut = autonome).
- Remboursement de l'ergothérapeute + pharmacien : chez les > 75 ans.

5 PSG & interdisciplinarité

van der Bruggen & Marien — Programme de Soins Gériatrique, liaison, interdisciplinarité.

TUYAU — Les 5 axes du PSG **RÉCURRENT (2021, 2018...)**

« Le PSG : vrai/faux » / « la LIG, un des 5 axes ».

Le PSG (**arrêté royal du 29/01/2007**, âge cible ≥ 75 ans) organise les soins de la PA dans l'hôpital général en **5 axes** :

1. **Unité de gériatrie aiguë** (durée ~14 j, réunion pluri. hebdomadaire).
2. **Liaison interne gériatrique (LIG/EGL)** — équipe sur appel des unités non gériatriques.
3. **Consultation** de gériatrie.
4. **Hôpital de jour gériatrique** (bilan pluridisciplinaire).
5. **Liaison externe** (1^{re} ligne : MRS, domicile).

Niveau	Définition
Multi	savoirs juxtaposés , métiers en parallèle, sans réelle relation
Pluri	usage combiné avec transmission d'infos
Inter	but commun, décisions par consensus , synergie (la somme > addition)
Trans	interactions si fortes qu'elles créent une nouvelle discipline (psycho-/onco-/cardiogériatrie)

Exigences de l'interdisciplinarité : composantes formelle (réunions) + informelle (communication continue), objectif commun, flexibilité/chevauchement des rôles, gestion des conflits, accepter ses limites, interdépendance. **PIÈGE** : ce n'est PAS « les autres se plient au médecin », ni un « objectif personnel ».

LIG / Équipe de liaison : appelée par tout soignant (pas seulement le MG, pas seulement un spécialiste), rôle de **2^e ligne** pour les patients fragiles hospitalisés **hors gériatrie** (dépistage → évaluation → recommandations de plan de soins), rôle **éducatif** — pas prioritairement « médical au sens prescripteur ».

6 Réadaptation gériatrique

Indications, critères d'exclusion, pronostic.

« Citez 4 critères d'exclusion d'une réadaptation gériatrique. »

- Patient **trop autonome/fit** (n'en a pas besoin).
 - **Démence trop sévère** (incapacité à coopérer/apprendre).
 - **Pathologie aiguë instable** (ou delirium actif → traiter d'abord).
 - Réadaptation **réalisable à domicile** / en ambulatoire.
 - **Soins palliatifs** indiqués (pronostic vital très limité).
- **Facteur de MAUVAIS pronostic : absence de motivation** ; déclin fonctionnel **chronique** (vs événement aigu limité = bon pronostic). La **nutrition** est indispensable au succès.
 - L'**âge n'est pas un facteur limitant** en soi (ex. réadaptation après fracture du col du fémur). La masse musculaire reste **gagnable même > 85 ans**.
 - Possible même avec **appui interdit** (travail du membre sain, transferts) et en MRS.

PARTIE II — Grands syndromes gériatriques

7 Chutes & syndrome de désadaptation psychomotrice

THÈME MAJEUR — tombe presque chaque année.

TUYAU — Citez 5 facteurs de risque de chute ≥ 4 × (chaque année)

« Citez 5 FR principaux de chute. »

1. **Antécédent de chute** (= FR n° 1).
2. **Médicaments** (psychotropes/BZD, anti-HTA, anticholinergiques, polymédication).
3. **Troubles de la marche & de l'équilibre** (sarcopénie, désadaptation, Parkinson).
4. **Troubles cognitifs** (jugement, double tâche).
5. **Hypotension orthostatique**.
6. + **troubles sensoriels** (vue/audition), **environnement inadapté**, **incontinence d'urgence**.

TUYAU — Attitude face à une chute (5 points) 2025

① évaluer les **conséquences** (traumatisme, station au sol prolongée → rhabdomyolyse) · ② préciser les **circonstances** · ③ rechercher les **causes potentielles** (cardio, neuro, métabolique, iatrogène) · ④ proposer une **EGS multidimensionnelle** · ⑤ mettre en place la **prévention** (interventions ciblées). Mnémo d'orientation : **SPLATT** (Symptoms, Previous falls, Location, Activity, Time, Trauma).

TUYAU — Syndrome de désadaptation psychomotrice (SDPM) TRÈS RÉCURRENT

« Signes cliniques » + « 2 formes (aiguë/chronique) + différences ».

Signes cliniques : rétropulsion du tronc (déjettement postérieur), **hypertonie oppositionnelle** (gegenhalten), **agrippement**, flexion des genoux, appui podal **postérieur**, **peur du vide antérieur**/de tomber (phobie), anxiété, réduction de la mobilité.

	Forme aiguë	Forme chronique
Début	Brutal (souvent après une chute)	Progressif
Réponse à la kiné	Bonne	Faible
Réversibilité	Réversible (bon pronostic)	Rarement réversible

PIÈGE : ce qui n'appartient PAS au SDPM = « souplesse du mouvement spontané » (au contraire : hypertonie/rigidité).

Démarche parkinsonienne (4 caractéristiques)

Absence de ballant des bras · **petits pas** (festination) · **freezing** (enrayage cinétique) · rigidité « roue dentée » · posture penchée en avant (≠ rétropulsion du SDPM).

Escarres & prévention

TUYAU — Stades des escarres & causes 2025, 2019

Stade	Description
1	Rougeur ne disparaissant pas à la vitropression (peau intacte)
2	Atteinte épiderme/derme : phlyctène, désépidermisation
3	Atteinte du tissu sous-cutané (graisse)
4	Atteinte muscle/os/tendon

4 causes : pression, cisaillement, friction, macération/humidité (+ immobilité, dénutrition). Une escarre sacrée peut apparaître en **3 h**. **Prévention** : mobilisation (couché : 2 h matelas normal / 4 h matelas dynamique), matelas adapté, nutrition, soins de peau, talons décollés.

8 Delirium (confusion aiguë)

Boland — THÈME N° 1 des examens.

TUYAU — Critères CAM : signes majeurs & mineurs TUYAU N° 1 (quasi chaque année)

« Citez 5 signes (majeurs et mineurs) du delirium / les critères de la CAM. »

Le diagnostic (CAM) requiert les **2 critères majeurs + au moins 1 mineur** :

- **MAJEUR 1 — Début aigu et évolution fluctuante**
- **MAJEUR 2 — Inattention** (déficit attentionnel)
- **MINEUR a — Pensée désorganisée** (discours incohérent)
- **MINEUR b — Altération de la vigilance/conscience** (hyper- ou hypoalerte)

Diagnostic = (Majeur1 ET Majeur2) ET (Mineur a OU b).

TUYAU — Cas « hallucinations, enfants dans la chambre, MRS, méfiance » ≥ 2 × (2020, 2022)

« 2 hypothèses diagnostiques + 3 tests / 3 FR (pas précipitants !). »

Hypothèses : ① **delirium hyperactif** (début aigu, fluctuant, fièvre 37,8 °C → cause organique) ; ② **démence à corps de Lewy** (hallucinations visuelles) ou **démence sous-jacente décompensée**. **Tests** : **CAM**, **biologie** (ionogramme, CRP, glycémie), **imagerie cérébrale (CT)**, ± analyse d'urines/recherche de foyer. **FR (prédisposants ≠ précipitants)** : âge, démence/troubles cognitifs, déficits sensoriels, comorbidités, antécédent de delirium.

8.1 Points-clés

- Le diagnostic implique de **chercher LA cause** (médicamenteuse, infectieuse, métabolique, fécalome, globe, douleur...). La CAM est un **outil diagnostique**, pas un score de gravité.
- **Forme hypoactive** = la plus fréquente et la **moins identifiée** (pronostic plus sombre). **Le delirium n'est PAS toujours agité.**
- Conséquences : ↑ mortalité (intra- ET post-hospitalière), ↑ durée de séjour, ↑ chutes, ↑ institutionnalisation, ↑ dénutrition.

- Prévention non pharmacologique +++ (réorientation, sommeil, hydratation, lunettes/prothèses auditives, mobilisation, éviter sondes/contention).

Pièges

- La **désorientation temporo-spatiale** n'est pas, à elle seule, un critère CAM (l'inattention l'est).
- Distinguer **FR prédisposants** (âge, démence...) des **facteurs précipitants** (médicament, infection, chirurgie).
- Delirium = **aigu/fluctuant/réversible** ; démence = chronique/progressive.

9 Démence / troubles neurocognitifs majeurs

Boland — THÈME MAJEUR (bilan diagnostique récurrent).

TUYAU — Bilan diagnostique d'un TNCM / démence **TRÈS RÉCURRENT (chaque année)**

« Quel bilan pour confirmer un TNCM ? (4-5 tirets) » / « 5 étapes de la démarche diagnostique ».

1. **Anamnèse + hétéro-anamnèse** (entourage : caractère progressif, retentissement sur les AVJ).
2. **Examen clinique** (neuro, sensoriel) + revue médicamenteuse.
3. **Tests cognitifs** : MMSE / MoCA (± bilan neuropsychologique).
4. **Biologie** : ionogramme, calcémie, glycémie, **TSH, B12, B9 (folates)** — exclure les causes réversibles.
5. **Imagerie cérébrale** (CT/IRM). ± ponction lombaire (biomarqueurs).

But : **exclure delirium et dépression**, écarter les causes curables, puis typer la démence.

TUYAU — Les 5 fonctions cognitives **2022**

Mémoire · Attention · Langage · Fonctions exécutives · Fonctions perceptivo-motrices / visuo-spatiales (+ cognition sociale dans le DSM-5).

TNCM (ex-démence) = déclin acquis d'≥ **1 domaine cognitif, persistant (> 6 mois)**, avec **retentissement sur l'autonomie (AVJ)**. Le **MCI** (trouble cognitif léger) = déclin SANS retentissement sur l'autonomie.

Type	Particularité
Alzheimer (la + fréquente)	Trouble mnésique progressif d'abord ; désorientation temporelle ; atteinte corticale
Vasculaire / mixte	Évolution en marches d'escalier ; FR cardiovasculaires
Corps de Lewy	Hallucinations visuelles, fluctuations, parkinsonisme ; hypersensibilité aux neuroleptiques
Fronto-temporale	Troubles du comportement/langage d'abord ; mémoire longtemps préservée

Pièges

- Pour diagnostiquer une démence : **exclure delirium et dépression** au préalable.
- Démence à corps de Lewy : **éviter les neuroleptiques** (hallucinations) — danger.
- Démence fronto-temporale : **mémoire préservée** au début (≠ Alzheimer).

10 Dépression & psychiatrie de la personne âgée

Deschietere.

TUYAU — Particularités de la dépression de la PA (vs adulte) 2025, 2022

« 6 différences de la dépression et de son traitement chez la PA. »

- **Présentation atypique** : plaintes somatiques, « masque » (hostile, conatif/apragmatique), **masque cognitif** (« pseudo-démence dépressive »).
- Risque **suicidaire élevé** (léthalité ++ : ~1 suicide réussi pour 3 tentatives, vs bien plus de tentatives chez le jeune).
- Souvent **sous-diagnostiquée** (banalisée, attribuée à l'âge).
- **Traitement** : ISRS en 1^{re} intention, « **start low, go slow** », délai d'action **plus long** ; **vigilance aux effets anticholinergiques (éviter les tricycliques)**.
- Comorbidités/iatrogénie fréquentes ; importance du contexte (deuil, isolement, pertes).
- Électroconvulsivothérapie : **pas en 1^{re} intention** (réservée aux formes sévères/résistantes).

TUYAU — SPCD chez un TNCM (nouveaux troubles du comportement) 2025

Devant des SPCD : ① **chercher une cause** (douleur, fécalome, globe, infection, delirium, médicament) · ② approche **non pharmacologique en 1^{re} intention** (environnement, routine, occupation) · ③ traiter la cause organique · ④ adapter la communication · ⑤ **éviter benzodiazépines/neuroleptiques** au long cours (réserver aux situations dangereuses, à dose minimale et courte) · ⑥ soutien de l'aidant.

Particularités de la psychiatrie de la PA : capacités d'adaptation diminuées, intrication somatique/cognitive/sociale, présentation atypique, nécessité d'écarter une cause organique (delirium), accès aux soins psychologiques moindre que chez le jeune. Une anxiété de novo chez une PA doit faire chercher : **dépression, delirium, déclin cognitif débutant, SPCD** (et non une schizophrénie de novo).

11 Déficits sensoriels

Boland & Gouget.

TUYAU — Bien communiquer avec un déficit auditif (5 mesures) 2022

1. Bon **éclairage, sans bruit de fond** ; se mettre **face** au patient (lecture labiale).
2. Se **rapprocher** (0,5–1,5 m), se présenter.
3. Parler **distinctement, lentement, sans crier** ; phrases courtes.
4. **Reformuler** et **valider** la compréhension réciproque.
5. Vérifier l'**appareillage** ; contact tactile, support écrit.

TUYAU — AVJ impactées par les déficits sensoriels 2024

« 5 activités à risque d'incident » : **alimentation** (inappétence, intoxication), **gestion des médicaments** (erreurs de pilulier), **déplacements/chutes, cuisine/brûlures-incendies, conduite automobile**, communication/vie sociale.

- **Presbyacousie** : perte neurosensorielle, bilatérale, symétrique, progressive, touchant les **fréquences AIGUËS d'abord** → « j'entends mais je ne comprends pas » (les aigus portent l'intelligibilité). Lien avec **isolement, dépression, déclin cognitif** ; appareiller = prévention. Déficits sensoriels = FR de **delirium**.
- **Goût/odorat** : leur baisse favorise **inappétence** → **dénutrition**.
- **Vue** : déficit fréquent chez la majorité des 75+ ; ↑ risque de chutes et de delirium. Scotome **central** = **DMLA** ; perte **périphérique** = **glaucome**.

Piège

L'intelligibilité dépend des **fréquences aiguës** (pas graves) ; la perte de l'odorat n'est **pas** rare ; la presbyacousie se traduit par « ne pas comprendre » plus que « ne pas entendre ».

12 Dénutrition & syndrome de renutrition

Marien & Etienne — THÈME MAJEUR.

TUYAU — Diagnostic de dénutrition : les « 3 piliers » ≥ 2x (2024, 2023)

« Donnez les 3 éléments / 3 pieds pour poser le diagnostic de dénutrition. »

Critères **GLIM** = **≥ 1 phénotypique** + **≥ 1 étiologique**. Les 3 axes phénotypiques :

1. **Perte de poids involontaire** (> 5 % en 1 mois ou > 10 % en 6 mois ; ≥ 5 kg/6 mois).
2. **IMC bas** (< 22 si ≥ 70 ans ; < 21 selon le cours).
3. ↓ **masse/force musculaire** (sarcopénie, ex. quadriceps 4/5).

+ critère **étiologique** : ↓ des apports (> 2 semaines) ou inflammation/maladie. Repères bio : **albumine** < **3,5 g/dl** (dénutrition ancienne), **MNA-SF** ≤ **7/14**.

TUYAU — 5 causes de dénutrition + prise en charge RÉCURRENT

« Citez en 5 mots 5 causes de dénutrition » + « 3 mesures avec 1 exemple ».

Causes (↓ **apports** / ↑ **besoins**) : troubles bucco-dentaires/déglutition · isolement/dépression · troubles cognitifs · iatrogénie (anorexie, dysgueusie) · maladie/inflammation/hypercatabolisme · troubles sensoriels (goût/odorat) · difficultés socio-économiques.

Prise en charge (par paliers) : ① **adapter l'alimentation** (texture, fractionnement, aide au repas) · ② **enrichir** (poudres protéinées) · ③ **compléments nutritionnels oraux (CNO)** en collation · ④ **nutrition entérale** (sonde) si échec.

12.1 Conséquences & besoins

Conséquences : sarcopénie/chutes, déclin fonctionnel, infections, retard de cicatrisation/escarres, ↑ toxicité médicamenteuse, troubles thymiques, ↑ mortalité. **Besoins** : énergie **30–40 kcal/kg/j**, protéines **1,2–1,5 g/kg/j**, eau ≈ 40 ml/kg/j.

12.2 Syndrome de renutrition inappropriée (SRI)

Apport brusque de **glucides** chez un dénutri → pic d'**insuline** → transfert intracellulaire massif de **phosphore, potassium, magnésium** + consommation de **thiamine (B1)**. Marqueur central = **hypophosphatémie**. Survient quelle que soit la voie (orale/entérale/parentérale), **même si la biologie initiale est normale**.

Prévention : renutrition **progressive** + supplémenter P/K/Mg + **thiamine AVANT** (prévention de l'encéphalopathie de Wernicke) + contrôle biologique J1–J3.

Pièges

- Diagnostic GLIM = **2 types** de critères (phénotypique + étiologique), pas un seul.
- Dénutrition possible chez l'**obèse** ; albumine/préalbumine ↓ aussi en **inflammation** (lire avec la CRP).
- Ne PAS donner de suppléments oraux « systématiquement à tous » ; dépister la déglutition, peser 1×/sem, soigner l'état buccal.

13 Troubles de l'élimination

de Saint-Hubert — incontinence, rétention/globe, fécalome.

TUYAU — Bilan diagnostique de l'incontinence : 3 premières étapes ≥ 3× (2024, 2023, 2020)

« 3 étapes pour avancer dans le diagnostic » / « 4 éléments du bilan ».

1. **Anamnèse** ciblée (type : effort/urgence/mixte ; ancienneté ; fréquence ; **calendrier mictionnel 48–72 h**) — chez la femme : « perte à l'effort/toux/rire ? » et « besoin urgent irréprouvable ? ».
2. **Examen clinique & fonctionnel** (abdomen, **TR/TV**, neuro, mobilité).
3. **Analyse d'urines** (exclure infection) + **bladder-scan** (résidu post-mictionnel ; normal < 50 ml).

TUYAU — Causes d'incontinence transitoire/réversible (mnémo DIAPPERS) 2021

« 5 causes d'incontinence urinaire transitoire à l'hôpital. »

DIAPPERS : Delirium · Infection urinaire · Atrophie vaginale · Pharmacie (anticholinergiques, diurétiques) · Psychologique (dépression) · Excès de diurèse (hyperglycémie) · Restriction de mobilité/contention · Stase stercorale (**fécalome**) + globe vésical.

Type d'incontinence	Mécanisme · sexe	Résidu
Urgence (la + fréquente)	Hyperactivité du détrusor	normal ou ↑
Effort	Insuffisance sphinctérienne ; ♀ (rééducation périnéale → niveau A)	0/faible
Regorgement	Trop-plein (obstacle prostatique / détrusor hypocontractile) ; ♂	important
Fonctionnelle	Mobilité/cognition/environnement	—

Causes fréquentes chez la femme : incontinence d'**effort** (insuffisance sphinctérienne post-obstétricale/ménopause, atrophie) et d'**urgence** (hyperactivité vésicale). **Modifications anatomiques** : ↓ tonus du plancher pelvien, atrophie vaginale/urétrale, ↓ capacité vésicale, prolapsus.

TUYAU — Rétention (globe) + fécalome : prise en charge aiguë 2021

Globe : drainage par **sondage in-out / bladder-scan**, puis traiter la cause (obstacle, médicaments anticholinergiques/opioides). **Fécalome** : **toucher rectal**, **lavement + macrogol (4–6 sachets)**, extraction manuelle si besoin. Le fécalome peut donner de **fausses diarrhées**, un globe, une IRA, un delirium.

Conséquences de l'incontinence : ↓ qualité de vie, ↑ delirium, escarres, chutes, épuisement de l'aidant, institutionnalisation.

14 Troubles hydro-salins

Boland — THÈME MAJEUR (bio-type récurrent : Na 154, urée 80...).

TUYAU — Hyponatrémie / déshydratation : traitement (3 points)

TRÈS RÉCURRENT (2025, 2024, 2023, 2020)

Bio type : Na⁺ 154, urée 80, acide urique 10, créat 1,2, Hb ↑ → « 3 points du traitement du trouble hydro-salin ».

- **Diagnostic : déshydratation hyponatrémique** (déficit en eau pure) — Na↑, urée↑, acide urique↑, hémococoncentration (Hb↑).
- ① **Réhydrater par eau libre** (per os si possible, sinon **G5 % IV**) ; ② **correction LENTE** (max ≈ 1 L/12 h ; ne pas baisser la natrémie de > 10 mmol/L par 24 h → risque d'œdème cérébral) ; ③ **traiter la cause** (apports insuffisants, fièvre, diabète) et **surveiller** iono + diurèse.
- Calcul du déficit hydrique ≈ eau corporelle × (Na/140 - 1) ≈ 3 L.

TUYAU — Hyponatrémie (ex. Na 126, sous ISRS) 2021

Base du traitement = **restriction hydrique** (~750 ml/j) + **arrêt/réduction de l'ISRS** (cause fréquente de SIADH chez la PA). Une hyponatrémie peut refléter le capital sodé, les apports, le DFG, ou un **excès d'eau**.

Régulation hydro-saline chez la PA (fragilisée) : ↓ sensation de soif, ↓ néphrons, ↓ pouvoir de concentration (gradient cortico-médullaire), ↓ RAA, sécrétion d'ADH plutôt augmentée/dérégulée. **Conséquences d'un déficit en eau de 10 % :** ↑ natrémie, ↑ Hb (hémococoncentration), hypotension, ↓ volume cellulaire (hypertonie), ↓ performances cognitives.

15 Infections de la personne âgée

Schoevaerdt — bactériurie asymptomatique, BLSE/MRSA, pneumonie d'inhalation.

TUYAU — Pourquoi plus d'infections chez la PA : les 4 groupes de causes ≥ 2× (2025, 2022)

« 4 grands groupes de causes favorisant les infections + exemples. »

Groupe	Exemples
Liés au patient	Immunosénescence, vieillissement des organes, fragilité, comorbidités, dénutrition, déclin fonctionnel
Liés aux pathogènes	Clones virulents, résistances (BLSE, MRSA)
Liés aux procédures/dispositifs	Sondes urinaires, cathéters, corps étrangers, chirurgie
Liés à l'environnement	Promiscuité (MRS/hôpital), transferts, hygiène des mains, charge de travail

TUYAU — Bactériurie asymptomatique : NE PAS traiter ≥ 2 × (2022, 2021)

Cas : 10^5 germes + leucocytes, **sans symptôme**.

Une **bactériurie asymptomatique ne se traite PAS** par antibiotique (même chez le diabétique, même sur sonde), car elle est très fréquente chez la PA institutionnalisée. **Seule exception** : avant un **geste urologique invasif** (ex. cystoscopie/RTUP avec effraction muqueuse). Diagnostic d'infection urinaire = bactériurie + **symptômes**.

TUYAU — Pneumonie d'inhalation : 5 interventions 2025

① **antibiothérapie** couvrant les anaérobies/germes oro-pharyngés · ② **évaluation de la déglutition** (logopède) + adaptation des textures · ③ **positionnement** (assis aux repas, demi-assis) · ④ **soins bucco-dentaires** · ⑤ **kiné respiratoire** + révision des médicaments sédatifs/anticholinergiques (qui altèrent la déglutition).

BLSE (bêta-lactamases à spectre étendu) : portage favorisé par les **antibiothérapies répétées**. **MRSA** : portage nasal, plaies chroniques, dépistage et plan de décolonisation. Infections nosocomiales : les **respiratoires** ont la mortalité la plus élevée. Présentation souvent **atypique/peu fébrile** (37,5 °C, voire hypothermie = gravité).

16 Ostéoporose, fractures & escarres

Schoevaerdt — métabolisme osseux, Garden, traitement.

TUYAU — Traitement de l'ostéoporose + conseils ≥ 2 × (2025, 2017)

Ostéodensitométrie T -3 (hanche) / -2,8 (colonne) → « 2 médicaments + 5 conseils ».

Médicaments : bisphosphonate (1^{re} intention, ex. alendronate) + **calcium & vitamine D** (socle).

Alternatives : dénosumab, SERM, analogue de la PTH (tériparatide).

5 conseils (bisphosphonate oral) : ① **à jeun le matin**, avec un **grand verre d'eau** · ② rester en **position debout/assise ≥ 30 min** (éviter l'œsophagite) · ③ pas d'autre prise (Ca, café) dans l'heure · ④ **soins/bilan dentaire** (risque d'ostéonécrose de la mâchoire) · ⑤ assurer un statut vitaminique D correct + activité physique + prévention des chutes.

Thème	À retenir
T-score	< -2,5 DS = ostéoporose ; -2,8 au col → risque de fracture > 20 % à 10 ans
Classification de Garden (col du fémur)	I (incomplète, engrenée) → IV (complète, déplacée). Trait complet + coxa vara + déplacement = Garden III-IV
Métabolisme osseux	Avec l'âge : ↑ PTH, ↓ vitamine D, balance résorption > formation ; apports Ca ≈ 1200 mg/j

TUYAU — 5 facteurs de l'évolution de la masse osseuse 2025

Âge · **statut hormonal** (ménopause, ↓ œstrogènes) · apports **calcium & vitamine D** · **activité physique** (charge mécanique) · génétique/pic de masse osseuse · médicaments (corticoïdes), tabac/alcool.

17 Constipation & diarrhée

Troubles digestifs fréquents (vignettes Parkinson).

- **Constipation (hypothèses) :** iatrogène (**opioïdes/tramadol**, anticholinergiques, fer), dysautonomie (Parkinson), déshydratation, immobilité, **fécalome**, hypokaliémie/hypothyroïdie, obstacle (cancer colique).
Soulager : hydratation + fibres, **macrogol**, mobilisation, revoir les médicaments constipants.
- **Diarrhée (causes) :** **fausses diarrhées sur fécalome**, **colite à C. difficile** (post-antibiotique, ex. quinolone), iatrogène (laxatifs, L-dopa, ISRS), infectieuse, cause organique. **Actions prioritaires :** TR (fécalome ?), examen des selles/coproculture + *C. difficile*, ionogramme/hydratation, revue médicamenteuse.

PARTIE III — Cardio, urgences & médicaments

18 Cardio-gériatrie

HTA, hypotension orthostatique & syncope, insuffisance cardiaque, FA.

TUYAU — Syncope post-prandiale / mécanismes de l'HO TRÈS RÉCURRENT (2025, 2022, 2020/21)

Cas : chute avec perte de connaissance ~45 min après le repas, sous anti-HTA → « cause la plus probable + 4 autres causes » / « 3 mécanismes d'HO ».

Cause la plus probable = hypotension orthostatique POST-PRANDIALE (séquestration sanguine splanchnique après le repas + anti-HTA + dysautonomie).

4 autres causes de syncope : médicamenteuse (anti-HTA, diurétiques) · cardiaque/arythmie · vaso-vagale (réflexe) · neurologique/mécanique ou indéterminée.

3 mécanismes d'HO chez la PA : ① hypovolémie (diurétique) · ② **vasoconstriction émuoussée** (α-bloquant, ↓ barorécepteurs) · ③ dysautonomie (diabète, Parkinson) / ↓ RAA (IEC).

TUYAU — Éviter l'HO SANS ajouter de médicament (4 mesures) 2021

① **Réviser/réduire les médicaments hypotenseurs** · ② **lever en 2 temps**, dormir tête surélevée, bas de contention · ③ **régime riche en sel et en eau**, repas fractionnés (éviter les gros repas) · ④ éviter chaleur/alcool, exercice doux des mollets.

TUYAU — Conséquences de l'IC à FE préservée (HFpEF) 2021, 2019, 2018

« 3 conséquences d'une IC à FE préservée chez la PA. »

Cœur « rigide » à remplissage diastolique altéré → **mauvaise tolérance** ① **de la fibrillation auriculaire** (perte de la contraction auriculaire), ② **de la tachycardie** (↓ temps de remplissage), ③ **des poussées de TA**. HFpEF = forme dominante chez la PA (> 50 % des décompensations) ; pronostic réservé (~50 % à 5 ans).

18.1 HTA & insuffisance cardiaque — points-clés

- **HTA** : présente chez > 50 % des PA ; « **start slow, go slow** » ; cible souvent < 140 (≤ 130/80 selon les recommandations) ; ne pas sur-traiter (chute/HO → STOPP).
- **IC** : diagnostic par **échocardiographie** ; ↑ réhospitalisations ; traitement globalement **identique au jeune** mais **monitoré** (souvent sous-utilisé).
- **Médicament précipitant une IC** : **AINS (diclofénac)**, corticoïdes, apports sodés (≠ IPP, ≠ spironolactone).
- **FA** : anticoaguler selon le risque (la chute n'est pas une CI).

19 Urgences & soins intensifs

Sibille — (absent de l'examen 2025, mais récurrent avant).

TUYAU — Admission d'une PA aux soins intensifs ≥ 2x (2023, 2022)

« 2 questions à se poser » + « 3 critères d'admission en USI ».

2 questions (Vincent & Creteur) : ① l'admission peut-elle **améliorer/assurer la qualité de vie** après les USI ? ② le patient a-t-il une **chance raisonnable de récupérer** une vie de qualité ?

3 critères d'admission : ① **instabilité hémodynamique** (choc) · ② **détresse respiratoire** · ③ **bénéfice médical** (potentiel de récupération).

L'ÂGE seul n'est PAS un critère : ce sont la fragilité et la fonctionnalité qui priment. Décideur = médecin intensiviste.

TUYAU — Définir l'acharnement thérapeutique 2022

= poursuite de traitements (diagnostiques/curatifs) **disproportionnés**, sans bénéfice raisonnable pour le patient (pas d'amélioration ni de récupération attendue), prolongeant la vie sans qualité = **obstination déraisonnable**. « Un médecin ne peut être contraint à un traitement inutile » ; « permettre de mourir n'est pas donner la mort ».

Signes de sévérité chez la PA : TAS < 110–120 mmHg ; FC < 50 ou > 100/min ; **apyrexie/hypothermie** ; défaillance d'organe (dont delirium). **Aux SI :** bundle ABCDEF, **éviter les benzodiazépines** (préférer dexmédétomidine), **mobilisation précoce** (mesure multi-bénéfice). **Syndrome d'immobilisation :** HO après quelques jours d'alitement, escarre sacrée possible en 3 h, constipation, déformations, ↓ capacité à l'effort (pas uniquement musculaire).

20 Pharmacologie & déprescription

Spinewine / Dalleur — THÈME MAJEUR.

TUYAU — Cascade médicamenteuse oxybutynine → donépézil TRÈS RÉCURRENT (2023 x2, 2018)

Dame HTA/incontinence/démence/insomnie : amlodipine, **oxybutynine**, donépézil, zolpidem, tramadol → « cascade + quel médicament déprescrire en priorité, comment, alternative ».

- **Cascade :** l'**oxybutynine (anticholinergique)** aggrave les troubles cognitifs → on ajoute du **donépézil** (anticholinestérasique) = duo **antagoniste** absurde.
- **À déprescrire en priorité :** l'**oxybutynine** (anticholinergique : confusion, rétention, chute) — **comment** : arrêt (sevrage progressif), **alternative** : mirabégron (β-3) ou, mieux, mesures non pharmacologiques (rééducation, mictions programmées).
- Déprescrire aussi le **zolpidem** (chutes ; sevrage progressif, alternative = mélatonine/hygiène du sommeil).

TUYAU — Cascade chute → tramadol → ... TRÈS RÉCURRENT (2025, 2022)

Tableau à compléter : pathologie → traitement → nouvelle patho → nouveau traitement.

Chute/fracture → **tramadol** (douleur) → **constipation + troubles cognitifs/delirium** → on ajoute **halopéridol + diazépam** → **sédation/aggravation cognitive + immobilité** → **escarre**. Bonne attitude : traiter la cause, antalgie par paracétamol, laxatif, éviter d'empiler les psychotropes.

TUYAU — Anticholinergiques : reconnaître + effets 2024

Médocs : amlodipine, furosémide, IPP, aspirine, **fésotérodine (Toviaz)** → « prend-il des anticholinergiques ? effets SNC + périphérique ? ».

Anticholinergique ici = **fésotérodine/oxybutynine** (anti-muscariniques vésicaux), + tricycliques, certains anti-H1, neuroleptiques. **Effet central (SNC)** : confusion/delirium, troubles cognitifs, somnolence. **Effets périphériques** : bouche sèche, constipation, **rétenction urinaire**, vision floue, tachycardie. → calculer la charge anticholinergique.

TUYAU — 5 médicaments à diminuer/arrêter (cas Mr C / De St-Hubert) TRÈS RÉCURRENT

HTA, prostatisme, DT2, chute (hypoTA), bouche sèche ; IEC, tamsulosine, lormétazépam/BZD, BB, metformine, diurétique, aspirine.

- **Lormétazépam (BZD)** → chutes/confusion (à arrêter, sevrage progressif).
- **Tamsulosine** (α -bloquant) → **HO**/chute.
- **Diurétique ($\pm$ IEC)** → hypovolémie/HO.
- **Metformine** → si **IR sévère** (DFG bas) : contre-indiquée.
- **Aspirine** en prévention **primaire** → bénéfice/risque défavorable.

20.1 Cadres à connaître

Notion	Contenu
PK liées à l'âge	$\uparrow$ fraction libre ($\downarrow$ albumine) · $\uparrow$ Vd des lipophiles · $\downarrow$ clairance rénale (adaptation des doses)
3 prescriptions inappropriées	OVER (pas/plus d'indication) · MIS (mauvaise dose/choix/interaction) · UNDER (omission — âgisme)
STOPP / START	médicaments à arrêter / à introduire
Déprescription	1 médicament à la fois, sevrage progressif, décision partagée, suivi
EIM	5–20 % des hospitalisations, 40–50 % évitables

Exemples de prescription inappropriée : aspirine en prévention primaire, AINS + anticoagulant, fentanyl/opiacé sans laxatif, IPP > 8 sem sans indication, neuroleptique pour anxiété. **Sous-prescription (underuse)** : pas d'anticoagulant en FA, pas de Ca+vit D après chute, START aide à la corriger ; **ne PAS donner d'aspirine en prévention primaire n'est PAS une sous-prescription.**

21 Conciliation médicamenteuse & concordance

Marien / Dalleur.

TUYAU — Vignette « endocardite » : la cascade conciliation + concordance

TRÈS RÉCURRENT (2024, 2023, 2022)

« 2 transitions à risque · nom du processus · question pour l'exhaustivité · 3 choses à discuter pour le suivi ».

- **Transitions à risque** : admission/sortie d'hôpital, admission/sortie de MRS, transferts (+ « contacts à risque » : spécialistes, pharmacie/OTC, dentiste).
- **Processus = conciliation (réconciliation) médicamenteuse**, en 4 mots-clés : **Comparer** → **Identifier** → **Décider** → **Communiquer** (la **communication** est la plus importante : transmettre la liste réconciliée).
- **Question d'exhaustivité** : « Prenez-vous **autre chose** : gouttes, inhalateurs, patchs, médicaments sans ordonnance, plantes, médicaments d'une amie ? » (= reconstituer le BPMH).
- **Concordance/adhésion à la sortie (3 points)** : simplifier le schéma (pilulier), expliquer indication/effets, tenir compte des préférences/coût (décision partagée).

Terme	Sens
Compliance / observance	Le patient « obéit » (modèle paternaliste)
Adhésion	Le patient suit la prescription (plus actif)
Concordance	Décision partagée , négociée (shared agreement)

Non-adhésion chez la PA : 30–50 %. **Causes de non-compliance + solutions** : schéma complexe (→ simplifier/pilulier), troubles cognitifs (→ aide de l'entourage), effets indésirables (→ revoir le traitement), coût (→ adapter), mauvaise compréhension (→ éducation).

22 Discernement, projet thérapeutique, palliatif & aidants

Schoevaerds / Cornette.

TUYAU — Capacité de discernement : acronyme CARE **TRÈS RÉCURRENT (2025, 2024, 2023)**

« Que regarde-t-on pour apprécier la capacité de discernement ? » / « Un patient Alzheimer est-il incapable de discerner ? »

CARE — 4 éléments :

- **C — Compréhension** de l'information (maladie, options).
- **A — Appréciation** de la situation et de ses conséquences pour soi.
- **R — Raisonnement** (capacité à comparer les options de façon logique).
- **E — Expression** d'un choix clair et stable.

Alzheimer ⇒ incapable de discerner ? NON : ① le discernement s'évalue **au cas par cas et pour une décision donnée** (capacité graduée, fluctuante) ; ② un trouble cognitif léger/modéré peut conserver le discernement pour des décisions simples → ne pas présumer l'incapacité.

TUYAU — Les 5 étapes d'ICOPE **2023**

ICOPE : ① **dépistage** des capacités intrinsèques · ② **évaluation** approfondie · ③ élaboration du **plan de soins personnalisé** · ④ **suivi/monitoring** · ⑤ mobilisation des **ressources communautaires/territoriales**.

TUYAU — 3 besoins de l'aidant proche **≥ 2x (2025, 2024)**

① **Information/formation** (sur la maladie, les aides) · ② **soutien & répit** (prévenir l'épuisement : gardes-malades, centres de jour, court séjour) · ③ **reconnaissance & soutien psychologique/social** (être écouté, associé aux décisions). L'aidant est un acteur incontournable, à risque d'**épuisement**.

Soins palliatifs / projet thérapeutique : parler de la fin de vie améliore le vécu de la famille ; les soins palliatifs ne commencent pas seulement « quand le curatif est terminé » (approche précoce/mixte) ; il s'agit d'une **compréhension partagée médecin-patient** (advance care planning, directives anticipées). Devant une demande d'arrêt de vie : écouter, explorer la demande, associer l'équipe et les proches (cadre légal belge).

ANNEXE B — Banque de questions d'examen

Questions **réelles récurrentes** (compil 2017–2025) et questions « **que le prof pourrait poser** » (inventées dans le même esprit), avec réponses.

Entraîne-toi à répondre avant de lire le corrigé vert.

Vieillesse, fragilité, EGS

Q1 Citez les 5 M de la gériatrie.

R1 **Mind · Mobility · Medications · Multi-complexity · Matters Most.**

Q2 (*inventée*) Expliquez le modèle 1+2+3 de Bouchon avec un exemple.

R2 (1) déclin physiologique du vieillissement, (2) maladie chronique, (3) facteur aigu décompensant. Ex. : DFG qui chute sous le seuil d'insuffisance rénale lors d'une déshydratation (3) chez un diabétique âgé (1+2).

Q3 Donnez un exemple de chacun des 4 niveaux de prévention.

R3 Primaire = vaccination ; Secondaire = dépistage (cancer, fragilité) ; Tertiaire = Ca+vit D après fracture/revalidation ; Quaternaire = arrêt des bisphosphonates/statines en fin de vie.

Q4 Vignette : femme dépendante pour les AVJi, aide-toilette 2×/sem, sténose aortique serrée. Quelle échelle de fragilité, quel grade, pourquoi ?

R4 **Clinical Frailty Scale (CFS)** — patiente « **modérément fragile** » (**≈ 6/9**) : aide pour les AVJ instrumentales et une partie des AVJ de base. Justification : échelle validée, pronostique, intégrant fonction + cognition + comorbidité ; adaptée au bilan pré-TAVI.

Q5 Quels critères de Fried + cotation ?

R5 Perte de poids, épuisement, faiblesse, lenteur de marche, faible activité physique. 0 = robuste, 1–2 = pré-fragile, ≥ 3 = fragile.

Q6 Donnez 5 caractéristiques (définition) de l'EGS + 5 de ses dimensions avec le test associé.

R6 Processus multidimensionnel, interdisciplinaire, → plan de soins individualisé/coordonné, visant fonction & qualité de vie, avec suivi. Dimensions/tests : fonctionnel (Katz/Lawton), locomoteur (TUG), cognitif (MMSE), thymique (GDS), nutritionnel (MNA), médicamenteux (STOPP/START).

Q7 3 (ou 4) caractéristiques communes des syndromes gériatriques.

R7 Fréquents, multifactoriels (FR communs), sévères, sous-diagnostiqués, prévenables/curables, touchant le fragile.

Chutes, delirium, démence, dépression

Q8 Citez 5 facteurs de risque de chute.

R8 Antécédent de chute (n° 1), médicaments, troubles de la marche/équilibre, troubles cognitifs, hypotension orthostatique (+ sensoriels, environnement, incontinence d'urgence).

Q9 Syndrome de désadaptation psychomotrice : 4 signes + 2 formes et leurs différences.

R9 Rétropulsion du tronc, hypertonie oppositionnelle, agrippement, peur du vide antérieur (+ flexion genoux, appui podal postérieur). Forme **aiguë** (brutale, répond à la kiné, réversible) vs **chronique** (progressive, peu réversible).

Q10 Citez 5 signes du delirium (majeurs/mineurs).

R10 Majeurs : début aigu/fluctuant + inattention. Mineurs : pensée désorganisée, altération de la vigilance. Diagnostic = 2 majeurs + ≥ 1 mineur (CAM).

Q11 (*inventée*) Quelle est la forme de delirium la plus fréquente et pourquoi est-elle dangereuse ?

R11 La forme **hypoactive** : la plus fréquente, souvent **non identifiée** (confondue avec une dépression/fatigue), de moins bon pronostic.

Q12 Quel bilan pour confirmer un TNCM ? (5 étapes)

R12 Anamnèse + hétéro-anamnèse ; examen clinique + revue médicamenteuse ; tests cognitifs (MMSE/MoCA, neuropsychy) ; biologie (TSH, B12, B9, ione, calcémie) ; imagerie cérébrale. Exclure delirium et dépression.

Q13 Citez les 5 fonctions cognitives.

R13 Mémoire, attention, langage, fonctions exécutives, fonctions perceptivo-motrices/visuo-spatiales (+ cognition sociale).

Q14 (*inventée*) Devant des hallucinations visuelles chez un parkinsonien dément, quel médicament faut-il éviter et pourquoi ?

R14 Les **neuroleptiques classiques** : hypersensibilité dans la **démence à corps de Lewy** (risque de syndrome malin, aggravation). Privilégier la recherche/correction des causes et le non pharmacologique.

Q15 6 particularités de la dépression de la PA.

R15 Présentation atypique/masquée, masque cognitif (pseudo-démence), risque suicidaire létal, sous-diagnostic, ISRS « start low go slow » à délai long, prudence anticholinergique.

Nutrition, élimination, hydro-salin, infections, os

Q16 Les 3 « piliers » du diagnostic de dénutrition.

R16 Perte de poids ; IMC bas ; $\downarrow$ masse/force musculaire (+ critère étiologique : $\downarrow$ apports ou inflammation). GLIM = ≥ 1 phénotypique + ≥ 1 étiologique.

Q17 (*inventée*) Pourquoi un syndrome de renutrition peut-il survenir malgré une biologie normale, et quelle vitamine donner avant de renourrir ?

R17 Les stocks intracellulaires (P, K, Mg) sont vides malgré une biologie sanguine normale ; la renutrition glucidique provoque leur transfert intracellulaire (hypophosphatémie). Donner la **thiamine (B1) AVANT** (prévention de l'encéphalopathie de Wernicke).

Q18 Incontinence : 3 premières étapes du bilan.

R18 Anamnèse (+ calendrier mictionnel 48–72 h), examen clinique/fonctionnel (TR/TV), analyse d'urines + bladder-scan (résidu).

Q19 5 causes d'incontinence transitoire (mnémo).

R19 DIAPPERS : Delirium, Infection, Atrophie, Pharmacie, Psychologique, Excès de diurèse, Restriction de mobilité, Stase stercorale (fécalome).

Q20 Bio : Na 154, urée 80, acide urique 10, créat 1,2. Diagnostic + 3 points du traitement.

R20 Déshydratation hypernatrémique (déficit en eau pure). Réhydrater (eau po / G5 % IV), **lentement** ($\leq \sim 1$ L/12 h, $\downarrow$ Na < 10 mmol/L/24 h), traiter la cause + surveiller iono/diurèse.

Q21 Femme en MRS, urines troubles, 10^5 Klebsiella + leucocytes, asymptomatique. Faut-il traiter ?

R21 **Non** : bactériurie asymptomatique → pas d'antibiotique (sauf avant geste urologique invasif). Traiter seulement si symptômes.

Q22 Ostéoporose (T –3) : 2 médicaments + 3 conseils de prise du bisphosphonate oral.

R22 Bisphosphonate + calcium/vitamine D. Conseils : à jeun avec grand verre d'eau, rester debout ≥ 30 min, bilan dentaire (ostéonécrose).

Q23 (*inventée*) Fracture du col : trait complet, coxa vara, déplacée → classification ?

R23 Garden **III–IV** (complète déplacée).

Cardio, USI, médicaments, éthique

Q24 Chute avec perte de connaissance 45 min après le repas, sous anti-HTA : cause la plus probable + 4 autres causes de syncope.

R24 **HO post-prandiale**. Autres : médicamenteuse, arythmie/cardiaque, vaso-vagale, neuro/indéterminée.

Q25 3 conséquences d'une IC à FE préservée chez la PA.

R25 Mauvaise tolérance de la FA, de la tachycardie, des poussées de TA.

Q26 (*inventée*) Quel antalgique/anti-inflammatoire peut précipiter une décompensation cardiaque ?

R26 Les **AINS** (ex. diclofénac) : rétention hydrosodée + néphrotoxicité.

Q27 3 critères d'admission d'une PA en USI + 2 questions à se poser.

R27 Instabilité hémodynamique, détresse respiratoire, bénéfice médical. Questions : peut-on améliorer/assurer la qualité de vie après ? a-t-il une chance raisonnable de récupérer ? (l'âge seul n'est pas un critère).

Q28 Identifiez la cascade : incontinence traitée par oxybutynine, puis donépézil. Que déprescrire en priorité, comment, alternative ?

R28 Cascade anticholinergique (oxybutynine) → aggravation cognitive → donépézil (antagonisme). Déprescrire l'**oxybutynine** (sevrage progressif) ; alternative : mirabégron ou mictions programmées/rééducation.

Q29 4 mots-clés de la conciliation médicamenteuse ; lequel est le plus important ?

R29 Comparer, Identifier, Décider, **Communiquer** (le plus important : transmettre la liste réconciliée évite les erreurs aux transitions).

Q30 Que regarde-t-on pour apprécier la capacité de discernement (acronyme) ? Un patient Alzheimer en est-il forcément privé ?

R30 **CARE** : Compréhension, Appréciation, Raisonnement, Expression. Non : le discernement s'évalue par décision, de façon graduée — un Alzheimer léger/modéré peut décider pour des choix simples.

Q31 3 besoins de l'aidant proche.

R31 Information/formation ; soutien & répit (anti-épuisement) ; reconnaissance & soutien psycho-social.

Q32 Les 5 étapes d'ICOPE.

R32 Dépistage → évaluation → plan de soins personnalisé → suivi → ressources communautaires.

Synthèse réalisée à partir des supports WMDS2238 (UCLouvain / Cliniques universitaires Saint-Luc) et vérifiée contre la compilation d'examens 2017–2025. Document de révision — confirme toujours les seuils litigieux sur les diapositives originales. Les corrigés s'appuient sur les réponses-types de la compil et les recommandations gériatriques standard.